UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Réanimation
Intoxication aux opiacés sans patient
Avec PSS
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Sarah Bennan **Date de rédaction :** 29 /02/2024

Situation de départ N° 28 – Coma et troubles de conscience

Domaine de compétence n°1 : Stratégie de prise en charge

Domaine de compétence n°2 : Communication interprofessionnelle

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Évaluer le degré d'urgence de la prise en charge

2- Échanger avec les différents intervenants pour la réalisation des explorations diagnostiques et thérapeutiques

Patient simulé nécessaire à la station : Pas de patient mais présence d'un <u>professionnel de santé standardisé : PSS</u> :

- **Une infirmière en réanimation.**

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- **Aucun matériel nécessaire :** <u>prise en charge thérapeutique uniquement dictée au téléphone.</u>

Exemple d'instructions au PSS : Infirmière

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Professionnel de Santé Standardisé : PSS

Vous êtes infirmière en réanimation. Vous recevez dans le service une nouvelle entrée : un patient de 58 ans, Mr Hubert, en coma calme.
L'interne n'étant pas présent dans le service au moment de l'arrivée de votre patient, vous l'appelez pour discuter de la prise en charge immédiate devant cette urgence.

Vous disposez du compte rendu des urgences avec les informations nécessaires pour répondre aux interrogations de l'interne sur la clinique du patient.

Vous discutez avec l'interne du service ses suspicions diagnostiques et de la prise en charge à instaurer en urgence.

Voici les informations dont vous disposez sur le patient ainsi que le scénario de la station :

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Hubert Prénom : Yves Age : Cuisinier Marié, 2 enfants, Vis à Grasse.
Antécédents	Aucun
Médicaments actuels/ Toxiques	*Alcoolisme chronique*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : Allongé, inconscient, en coma calme
Déroulement du scénario	Vous êtes infirmière, présente dans le service de réanimation lorsque le patient arrive avec le SMUR. Vous appelez l'interne responsable au téléphone pour lui annoncer l'entrée : ***« Allo, je t'appelle pour te dire que Monsieur Hubert, 58 ans est arrivé des urgences pour Coma calme. C'est assez urgent je crois. Est-ce que tu as des questions sur le patient ? »***

	Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. N'hésitez pas à préciser le degré d'urgence de la situation. **« Il ne va pas bien du tout, je t'appelle pour savoir ce que je dois faire en urgence avant ton retour** »
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Si l'étudiant ne propose pas de diagnostic ni de prise en charge à 2 minutes de la fin dites-lui « A quel diagnostic penses-tu ?? Que dois-je faire en urgence ? »

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
L'utilisation du jargon médical est attendue entre l'infirmière et l'interne. *Si vous ne disposez pas de la réponse à la question, vous pouvez répondre* *« Je ne sais pas »* *« Ce n'est pas inscrit dans le compte rendu des urgences » ou « je n'ai pas cette information pour l'instant »*	
Le patient a-t-il des troubles de la vigilance ?	Oui, patient Glasgow 10.
Le patient présente -t-il des signes de détresse respiratoire : tirage sus claviculaire, respiration abdominale, cyanose, désaturation	non
Diagnostic différentiel : <u>Le patient a-t-il :</u> - Un syndrome méningé : une photo – phonophobie, une de raideur nucale - De la température - Un déficit focal, une paralysie faciale - Une plaie …	 NON NON NON
Recherche d'une défaillance hémodynamique	Pas de marbrure, de pli cutané ni d'hypotension.
Le patient a-t-il un myosis :	Oui myosis serré bilatéral
Le patient a-t-il une mydriase :	non
Le patient a-t-il une bradypnée ?	Oui
Qu'elle est la fréquence respiratoire du patient ?	12 cycles par minutes
Quelle est la saturation du patient	96%
Le patient a-t-il un antécédent connu ?	Non
Le patient a-t-il un globe urinaire	Oui
Le patient a-t-il une tachycardie	Non : FC 70
Le patient a-t-il une hypersudation	Non
Le patient a -t-il des hallucinations	Non
Quelle est l'histoire de la maladie ?	Le patient a été retrouvé inconscient au sol, chez lui par sa femme. Une boîte d'Oxynorm a été retrouvée par le SMUR.
Le patient a-t-il une obstruction des VAS	Non

Instructions à l'étudiant

Vous êtes **interne en service de réanimation**.

Alors que vous vous rendez dans un autre service pour effectuer un geste, l'**infirmière de votre service vous appelle** pour vous prévenir de l'arrivée du nouveau patient et pour vous demander la prise en charge immédiate.

Il s'agit de Monsieur Hubert, 58 ans, admis pour coma calme.

L'infirmière, Lucie, **dispose du contre rendu du SAU avec les éléments de l'examen clinique du patient ; vous pourrez l'interroger sur l'examen du patient.**

Vous correspondez au téléphone avec cette dernière.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Vous questionnez l'infirmière sur la situation clinique du patient et lui renseignez votre principale hypothèse diagnostique.
2. Vous indiquez à l'infirmière l'ensemble des éléments de la prise en charge en urgence de ce patient

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique du malade
- Expliquer votre jargon médical à l'infirmière

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Questionne sur l'état de vigilance du patient : demande le score Glasgow	
Recherche des signes de détresse respiratoire : tirage sus claviculaire, respiration abdominale, cyanose, marbrures, balancement thoraco-abdominale (cocher si 2/5)	
Questionne sur les diagnostics différentiels : recherche un sepsis, un syndrome méningé, de la fièvre, un déficit sensitivo-moteur, une plaie du scalp, une glycémie anormale (cocher si 2/6)	
Évalue les pupilles	
Évalue la fréquence respiratoire	
Recherche la présence d'un globe urinaire	
Explique à l'infirmière qu'il pense à une intoxication aux opiacés	
Tâche 2	
Cite la nécessité de libérer les voies aériennes	
Prescrit de l'oxygène en prévention d'une défaillance respiratoire	
Demande à Scoper le patient	
Demande la pose de 2 VVP	
Prescrit un bilan biologique comprenant : NFS, CRP, bilan hépatique, Créatinine, Urée (cocher si tous présents)	
Prescrit du naloxone IVD	
Explique à l'infirmière la titration de naloxone : une dose toutes les 2 min jusqu'à obtention d'une fréquence respi >15 et d'un Glasgow ≥ 12 *(pour éviter d'intuber le patient sans le réveiller totalement) (cocher si mentionne la titration jusqu'à amélioration des constantes respi et neuro)*	
Explique la nécessité de maintenir ensuite la perfusion de naloxone demi-dose (car la demi-vie est courte)	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Communication avec les pairs	1 à 5
Aptitude à faire la synthèse des données	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tâche 1	
Questionne sur l'état de vigilance du patient : demande le score Glasgow	1
Recherche des signes de détresse respiratoire : tirage sus claviculaire, respiration abdominale, cyanose, désaturation (cocher si 2/4)	1
Questionne sur les diagnostics différentiels : recherche un sepsis, un syndrome méningé, de la fièvre, un signe de localisation, une plaie du scalpe, une glycémie anormale (cocher si 2/6)	1
Recherche la présence d'un myosis serré	1
Recherche la présence d'une bradycardie respiratoire	1
Recherche la présence d'un globe urinaire	1
Explique à l'infirmière qu'il pense à une intoxication aux opiacés	1
Tâche 2	
Cite la nécessité de libérer les voies aériennes	1
Prescrit de l'oxygène en prévention d'une défaillance respiratoire	1
Demande à Scoper le patient	1
Demande la pose de 2 VVP	1
Prescrit un bilan biologique comprenant : NFS, CRP, bilan hépatique, Créatinine, Urée (cocher si tous présents)	1
Prescrit du naloxone IVD	1
Explique à l'infirmière la titration de naloxone : une dose toutes les 2 min jusqu'à obtention d'une fréquence respi >15 et d'un Glasgow ≥ 12 *(pour éviter d'intuber le patient sans le réveiller totalement)* (cocher si mentionne la titration jusqu'à amélioration des constantes respi et neuro)	1
Explique la nécessité de maintenir ensuite la perfusion de naloxone demi-dose *(car la demi-vie est courte)*	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Communication avec les pairs	1 à 5
Aptitude à faire la synthèse des données	
Aptitude à proposer une prise en charge	